

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMAKAIAN CPAP PADA BAYI		
	No.Dokumen 922.16/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Tindakan pemberian tekanan positif kontinu ke saluran napas bayi yang bernapas spontan melalui alat pernapasan hidung (<i>nasal prongs</i> atau <i>nasal mask</i>) untuk menjaga alveoli tetap mengembang, meningkatkan oksigenasi, dan mengurangi kerja napas (<i>work of breathing</i>).		
Tujuan	1. Mempertahankan kapasitas residu fungsional paru (FRC) 2. Mengatasi gangguan napas (seperti pada <i>Respiratory Distress Syndrome</i> / RDS, apnea prematuritas, atau pasca-ekstubasi) 3. Mencegah kolaps paru (atelektasis) dan meminimalkan kebutuhan akan intubasi endotrakeal (ventilator mekanik)		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor : 826.15/I-PDM/NICU/IX/2025 Tentang Pedoman Pelayanan NICU		
Prosedur	A. Persiapan Alat 1. Mesin CPAP/Bubble CPAP (lengkap dengan humidifier dan blender oksigen) 2. Cairan Steril (steril water 1000ml) untuk mengisi tabung generator dan humidifier 3. Sirkuit CPAP (selang inspirasi dan ekspirasi) sesuai jenis alat yang digunakan 4. Antarmuka Pasien : Nasal prong atau nasal mask dengan ukuran yang sesuai 5. Topi CPAP (Bonnet) sesuai ukuran lingkar kepala. 6. Pengukur tekanan (<i>Manometer</i>) dan pengukur aliran (<i>flow meter</i>) 7. Oksimetri nadi (<i>Pulse Oximeter</i>) 8. Suction dan kateter penghisap B. Langkah - Langkah 1. Verifikasi instruksi medis (target FiO2 dan PEEP) 2. Cuci tangan 6 langkah sesuai standar WHO 3. Siapkan alat dan pastikan sirkuit sudah terangkai serta humidifier terisi air 4. Identifikasi bayi menggunakan gelang identitas (Nama dan tanggal lahir) 5. Jelaskan tujuan pemasangan CPAP, prosedur pemasangan, dan resiko yang mungkin terjadi (luka diseptrum hidung akibat masker/prong) kepada orang tua bayi		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMAKAIAN CPAP PADA BAYI		
	No.Dokumen 922.16/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	6. Posisikan Bayi: Letakkan bayi dalam posisi telentang (<i>supine</i>) dengan bahu sedikit diganjal (<i>posisi sniffing</i>) untuk membuka jalan napas 7. Bersihkan Jalan Napas : Lakukan suction pada mulut dan hidung jika terdapat lender 8. Pasang Topi (<i>Bonnet</i>) : Pasang topi hingga menutupi telinga dan alis, pastikan tidak terlalu ketat namun stabil 9. Tentukan Ukuran Prong : Pilih nasal prong yang mengisi seluruh lubang hidung tanpa meregangkan cuping hidung 10. Atur Parameter Mesin : a. Flow : Biasanya 6–8 Liter/menit (sesuai instruksi dokter). b. PEEP (Tekanan) : Mulai dari 5–7 cmH₂O (sesuai instruksi dokter). c. FiO₂ : Mulai dari 21% (udara bebas) atau sesuai saturasi target. d. Suhu Humidifier: Atur antara 36,5°C – 37,5°C. 11. Pemasangan Prong : a. Hubungkan prong ke hidung bayi. b. Pastikan ada jarak 1–2 mm antara septum hidung dengan ujung prong untuk mencegah nekrosis (luka) pada sekat hidung. c. Fiksasi selang ke topi menggunakan alat fiksasi yang tersedia (tali/velcro). 12. Evaluasi Akhir : Pastikan tidak ada kebocoran udara yang besar dan posisi bayi tetap nyaman. 13. Lakukan Pemantauan & Observasi : a. Saturasi Oksigen: Pantau melalui <i>Pulse Oximeter</i> (target biasanya 90–95% untuk bayi prematur) b. Klinis: Amati usaha napas, frekuensi jantung, dan warna kulit c. Integritas Kulit: Cek area hidung setiap 2–4 jam untuk melihat tanda kemerahan atau luka d. Perut: Pasang pipa orogastrik (OGT) secara terbuka (open drain) untuk mencegah kembung akibat udara yang masuk ke lambung. 14. Dokumentasi : a. Catat waktu mulai pemasangan b. Catat parameter (Flow, PEEP, FiO₂) c. Catat respon bayi (Skor Downes setelah pemasangan) d. Catat ukuran prong yang digunakan		
Unit Terkait	Neonatal Intensive Care Unit (NICU)		